Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Jermain Alexander Vilches Herrera.				Sexo	F	M X
Fecha Nacimiento	3/05/2011	Edad actual	14 años	meses	País natal:	Chile	
Domicilio actual:	Girasoles 214 V. valle del Real				Teléfono	933477035	
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑				
Escolaridad actual:	8vo	Establecimiento	Liceo Nuevo Básica N°2.				

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 25/03/26	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Victor Castillo Villegas	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Papá	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 26/03/26	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Itania Barraza	Nombre:
Rol/cargo: Ed. Diferencial	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Actualización datos de anamnesis

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☑ Si **(especificar)**

Pediatría:	Psicología: ✓
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía: ✓
Fonoaudiología: ✓	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☑ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☐ cesárea (señalar motivo)

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☐ SI ☐ NO	Peso: 1k 400	Talla: 40 cm.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

- La madre presenta placenta previa.
- Nace prematuro de 34 semanas

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	~~Sí~~	No	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	No
Obesidad	Sí	~~No~~	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	No
Fiebre alta	Sí	~~No~~	Enfermedad respiratoria	~~Sí~~	No	Otra(s)		
Convulsiones	~~Sí~~	No	Asma	~~Sí~~	No			
Hospitalizaciones	~~Sí~~	No	Especifique motivos y duración: 45 días por ser prematuro					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~Sí~~	No		Vacunas	~~Sí~~ No

Observaciones:
a los 3 meses de vida comienza con episodios de convulsiones por fiebre alta. Estos cuadros mermaron a los 5 años.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: no recuerda	Se sienta sólo/a: no recuerda	Camina sin apoyo: 16,6 M
Primeras palabras: No Recuerdo	Primeras frases: No Recuerdo	Se viste solo/a: 3 a
Controla esfínter vesical Diurno: 2 a Nocturno: 2 a	Controla esfínter anal Diurno: 2 a Nocturno: 2 a	

Observaciones:
a los 3 años con 2 meses estuvo hospitalizado por neumonía (pulmones obstruidos)

En su actividad motora general se aprecia: ☐ normal ☑ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo	**Su tono muscular general se aprecia:** ☐ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral	~~Sí~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	Sí	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Sí~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

Observaciones:
Sin antecedentes relevantes

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	✓	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	✓	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	~~No~~ ✓	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	~~Sí~~ ✓	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	~~No~~ ✓	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	~~Sí~~ ✓	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	~~No~~	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	~~No~~ ✓
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	~~No~~	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	~~No~~ ✓
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	~~No~~ ✓	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	~~No~~
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	~~No~~	La pronunciación oral es adecuada	Sí	~~No~~
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	~~No~~ ✓	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	~~No~~ ✓

Observaciones: Sin antecedentes relevantes

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☑ oral ☐ gestual ☐ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Si	No	Emite/produce frases	Si	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Si	No	Relata experiencias	Si	No
Emite palabras/produce señas	Si	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No

Características del lenguaje comprensivo

Identifica objetos	Si	No	Sigue instrucciones simples	Si	No
Identifica personas	Si	No	Sigue instrucciones complejas	Si	No
Comprende conceptos abstractos	Si	No	Sigue instrucciones grupales	Si	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Si	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Si	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): NO

Observaciones:

Sin antecedentes relevantes

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Si	No	Se relaciona en forma colaborativa	Si	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Si	No	Respeta normas sociales	Si	No
Participa en actividades grupales	Si	No	Respeta normas escolares	Si	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Si	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	Sonidos:	Personas extrañas:
☑ natural ☐ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

Sin antecedentes relevantes

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	Si	No	Trastorno motor	Sí	No
Epilepsia	Sí	No	Problema bronco-respiratorio	Si	No
Problemas cardiacos	Sí	No	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	No
Paraplejia	Sí	No	Trastorno emocional	Sí	No
Pérdida auditiva	Sí	No	Trastorno conductual	Sí	No
Pérdida visual	Sí	No	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):
Tratamiento por asma (salbutamol)

Alimentación: ☑ normal ☐ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☐ normal ☐ tranquilo ☑ inquieto Horas que duerme: 7 horas

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos ☐ sonambulismo ☑ despierta de buen humor	Duerme: ☑ solo ☐ acompañado (Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☑ risueño(a) ☐ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:

Sin antecedentes relevantes.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.				
Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Victor Castillo	Papá	43	8° básico	T. independiente
2. Jeremy Castillo	hermano	20	Universidad	Estudiante
3. Mª Angelica Villegas	Abuela	83		Jubilada
4. Gabriel Castillo	Abuelo	77		Jubilado
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Sin antecedentes relevantes.

Observaciones:

Sin observaciones

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar

Edad de ingreso al sistema escolar	3a, 10m	Asistió a jardín infantil		~~Sí~~	No
N° de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular ☐ Especial ☐ Técnica ☐:			
Motivo de los cambios: Escuela de Lenguaje Makiato a Liceo Mixto					
Ha repetido curso/s	Sí ✓	No	Curso(s) 6to	Motivo: Bajo rendimiento	

Situación actual

Nivel/curso actual	8vo		**Dificultad de aprendizaje**	Sí ✓	No	**Dificultad para participar**	Sí	No ✓	**Conducta disruptiva**	Sí	No ✓
Asiste regularmente	Sí ✓	No	Asiste con agrado	Sí ✓	No	Apoyo familiar en tareas	Sí ✓	No	Amigos (as)	Sí ✓	No

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?

☐ satisfactorio ☒ insatisfactorio (motivos) ....Le cuesta aprender.....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?

☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?

☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....

Especifique el tipo de refuerzos o premios:

☑ expresiones afectivas ☑ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☑ tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?

☑ madre ☑ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?

☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☐ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

- Jermain en la actualidad se encuentra enfrentando un juicio por vulneración de derechos.
- Paralelamente a este juicio don Víctor está solicitando cambio de apellido.
- Jermain asiste 1 vez al mes a terapia psicológica de forma particular.
- Desde muy pequeño Jermaín ha estado a cargo y al cuidado de don Víctor.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY